

Fecha Última Actualización: 15-08-2022 20:38:06

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : José Emilio Del Carm Fuentes Fuentes
Edad : 86a 7m 16d
Dirección : Troncal San Fco 2484

Rut : 4.271.790-8
Fecha Nacto: 30/12/1935
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1002275
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9548 8847

N° Epicrisis
316469

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 10/07/2022 03:12

Días Estadía : 36

Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Egreso : 15/08/2022 20:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: José Fuentes
RUT: 4271790-8
Edad: 86 años
FI CASR: 10/07/22
FI UTIM: 10/07/22
FI UCI: 14/07/22
Contacto: Viviana, hija (995488847)

Antecedentes:

- Mórbitos: ICC, ERC etapa V sin HD con crea 6.26 del 24/06, hiperparatiroidismo primario, FA en TACO, SCA SSDST en manejo médico (20/06)
- Quirúrgicos: colecistectomía
- Fármacos: TACO, amlodipino 5 mg al día VO, hidralazina 25 mg c/8 hrs, isosorbide 5 mg c/8 hrs, ATV 40 mg al día, bicarbonato de sodio 1 g cada 8 h, bisoprolol 1.25mg cada 24 h, AAS 100 mg al día, levotiroxina 25 mcg
- Alergias: niega
- Hábitos: niega
- Hospitalizaciones: Reciente en clínica vespucio, pendiente epicrisis, se describe que paciente rechazó HD y coronariografía.
- Social: Dependiente moderado ABVD.

Motivo de ingreso y evolución:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de 3 días de evolución de disnea progresiva de moderados a mínimos esfuerzos asociado a disminución del débito urinario. El día de la consulta presenta episodio de dolor torácico opresivo sin síntomas neurovegetativos asociados, aunque al interrogatorio niega. Sin palpitaciones. Sin fiebre, sin síntomas urinarios o gastrointestinales, si refiere tos días previos y odinofagia.

Ingresa en regulares condiciones, normocárdico, hipertenso, afebril, saturando 87% ambiental. Al examen se describe con yugulares ingurgitadas, con signología congestiva. En exámenes de laboratorio destaca parámetros inflamatorios bajos, TUS de ingreso negativa, sin recontrol, creatinina de 5 con BUN 55, hiperkalemia severa 6.94. ECG con bradicardia sinusal sin signos de isquemia. Radiografía de tórax de ingreso con cardiomegalia y congestiva.

Se maneja con VMNI + BIC de NTG + terapia depleitiva + medidas shift por hiperkalemia. Ingresa a UTIM para continuar

Fecha Epicrisis : 15/08/2022 20:38

Página 1 de 3

manejo.

En UTIM paciente evoluciona con mejoría parcial desde punto de vista ventilatorio, logrando destete de VMNI y paso a O2 por naricera. Se realiza TAC de torax el 13/07 que informa: Moderado derrame pleural bilateral, con atelectasias pasivas bibasales. Opacidad de relleno alveolar bilaterales. Considerar etiología inflamatoria infecciosa versus edema.

Posterior a toma de TAC paciente evoluciona con mayor compromiso de conciencia, asociado a requerimientos de O2 al alza hasta 5 Lt por NRC y mala mecánica ventilatoria, con FR de hasta 55 rpm. Con bradicardia que persiste, FC entre 40 y 45 lpm. Se interpreta como bradicardia inestable con EPA cardiogénico, se administran 20 mg de Furosemida en bolo, 0.5 mg de Atropina y se conecta a VMNI. Logra alza de FC sin embargo persiste con mala mecánica, mal acoplado a VMNI. Se decide intubación y conexión a VMI.

En lo hemodinámico se logra destete de NTG en infusión y se inicia terapia vasodilatadora oral. Posterior a compromiso de conciencia y deterioro ventilatorio cursa con bradicardia hasta 40 lpm que se interpreta como síndrome bradi taqui en contexto de enfermedad del nodo. Requiere inicio de DVA con NAD hasta 0.4 mcg/kg/min y dobutamina a 1.5 mcg/kg/min por mala contractilidad del septum. Sin evidencias de isquemia miocárdica aguda, con TUS en rango. Tras inicio de DVA e inotropas con mejoría de frecuencia cardíaca.

En lo renal con diuresis apoyada con furosemida pero con aumento progresivo de parámetros nitrogenados.

Dado decisión de manejo activo paciente se traslada a UCI para VMI y tratamiento.

Diagnósticos de ingreso a UCI:

1. Insuficiencia respiratoria aguda
 - a. Edema pulmonar agudo
2. Insuficiencia cardíaca descompensada
3. Obs enfermedad del nodo.
4. ERC etapa V

EVOLUCION

Evoluciona en UCI varios días con shock séptico y cardiogénico, además de requerimientos de ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal.

Con mejoría transitoria en que logra suspender drogas vasoactivas y destetarse de ventilador mecánico.

Egres a UTIM donde evoluciona con segundo shock cardiogénico y bradicardia, con reinicio de dopamina y noradrenalina, no pudiéndose realizar coronariografía. Además con múltiples intercurrentes infecciosas con ITS CVC por *Serratia marcescens* y *S. hominis*, sin respuesta a terapia antibiótica.

Destaca además mala tolerancia a hemodiálisis por hemodinamia y TAC de cerebro por compromiso de conciencia con múltiples infartos subagudos.

Progresivamente con requerimientos de oxígeno al alta hasta CNAF 55 L.

Tras 6 días de prueba terapéutica, ante futilidad de medidas, se acuerda con familiares manejo proporcional para confort.

Paciente fallece el 15/08/22 a las 19:20.

Se entrega certificado de defunción a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia cardíaca global -
Choque cardiogénico -
Neumonía bacteriana, no especificada -
Insuficiencia Renal Aguda -
Insuficiencia Respiratoria aguda -

Condición de Egreso

fallecido

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 15/08/2022 20:38

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:12

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Martín Aburto Marchant

Becado/Residente



José Antonio Jordan Ibarra

Médico Tratante (Staff)